

나와 가족을 위한 고혈압 예방과 관리 정보



예방과 관리 정보
고혈압
가족을 위한



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

나와 가족을 위한 고혈압 예방과 관리 정보

이 자료는 고혈압을 예방하고 관리하기 위해서 모든 국민이 실천해야 할
7대 생활 수칙과 실천 방법을 제시하고 있습니다. 우리 모두 정기적인
검진을 받고 올바른 생활습관을 가져 고혈압을 예방하기 위해 노력합시다.

CONTENTS

I. 고혈압 소개	04
-----------	----

II. 고혈압 예방과 관리 7대 생활 수칙	12
-------------------------	----

첫째, 싱겁게 먹습니다	14
--------------	----

둘째, 적정 체중과 허리둘레를 유지합니다	18
------------------------	----

셋째, 과일과 채소를 섭취합니다	22
-------------------	----

넷째, 규칙적으로 운동합니다	24
-----------------	----

다섯째, 금연합니다	28
------------	----

여섯째, 절주합니다	32
------------	----

일곱째, 정기적으로 혈압을 측정하고 검진합니다	34
---------------------------	----

III. 부록	38
---------	----

고혈압 소개

01 고혈압이란?

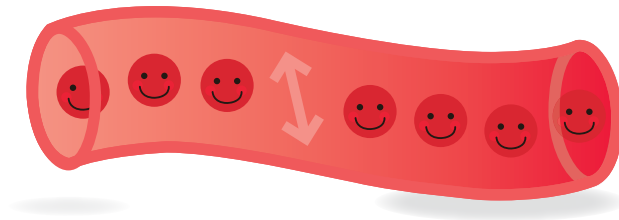
수축기 혈압

심장이 수축하여
혈액을 내보낼 때
혈관이 받는 압력

120/80

이완기 혈압

혈액이 심장으로
들어올 때 혈관에
미치는 압력



혈압

심장은 우리 몸에 산소와 영양소를 공급하기 위하여 분당 60~100회 정도 수축과 이완(확장)을 반복합니다. 이렇게 심장은 펌프처럼 혈액을 몸 구석구석까지 보내는데, 이때 혈액이 혈관 벽에 가하는 힘이 혈압입니다. 즉, 혈압은 혈관 내 압력을 수치로 나타낸 것입니다.

수축기 혈압

심장이 수축하여 혈액을 심장 밖 혈관으로 밀어낼 때의 압력을 수축기(최고) 혈압이라고 합니다.

이완기 혈압

심장이 확장할 때 혈관에서 유지되는 압력을 이완기(최저) 혈압이라고 합니다.

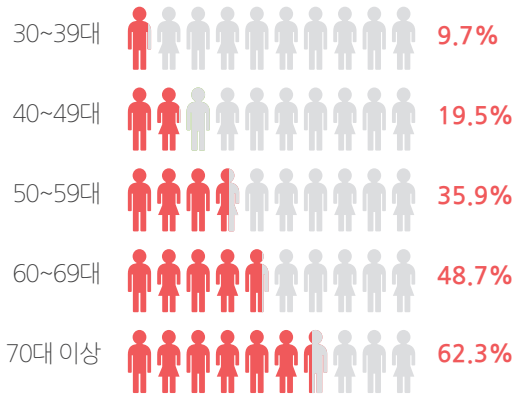
고혈압

혈압이 지속적으로 정상 기준보다 높을 때를 고혈압이라고 합니다.

백의 고혈압

백의 고혈압은 병원 고혈압 혹은 병원 단독 고혈압이라고도 하며, 일상생활에서는 혈압이 정상인데 반해 의료 환경에만 들어오면 혈압이 상승하는 것을 말합니다. 환자들은 진료실에 들어와서 혈압을 측정할 때 긴장하게 되는데 그 정도가 지나칠 경우 발생합니다.

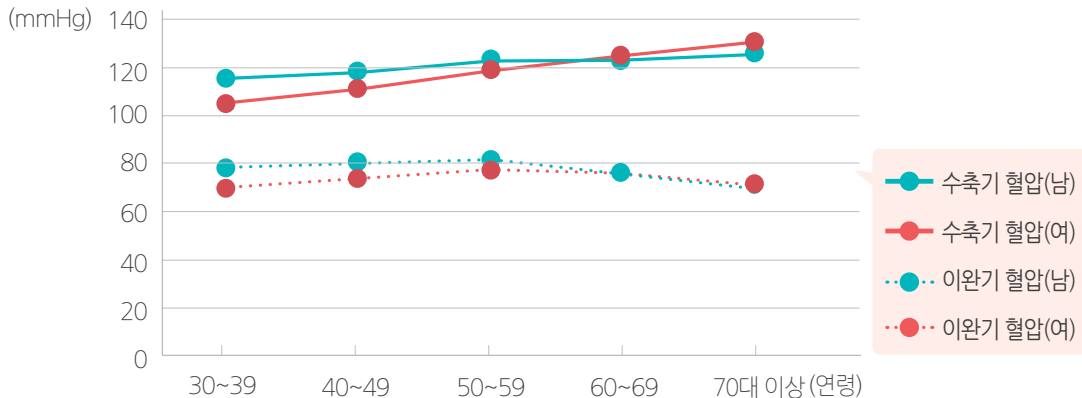
02 우리나라 고혈압 환자 현황*



우리나라 30세 이상 성인 10명 중 3명이 고혈압 환자입니다. 혈압은 연령이 증가할수록 상승하기 때문에 젊었을 때 혈압이 정상이라도 나이가 들면서 고혈압이 발생할 수 있습니다.

2013년 고혈압 유병률**

또한 60세가 넘으면 혈관의 노화 현상으로 수축기 혈압은 증가하지만 이완기 혈압은 다소 낮아져 위험성이 더 증가합니다.



연령에 따른 수축기와 이완기 혈압의 분포

참고

* 고혈압의 유병률 및 수축기와 이완기 혈압의 분포는 보건복지부와 질병관리본부의 「2013 국민건강통계」 자료를 참고

** 고혈압 유병률: 수축기 혈압이 140 mmHg 이상이거나 이완기 혈압이 90 mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 분율, 만 30세 이상

03 고혈압의 원인과 증상

고혈압의 종류와 원인

본태성 고혈압

고혈압 환자의 95%가 속하며 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않은 고혈압을 말합니다. 본태성 고혈압의 위험 요인은 나이, 가족력과 같이 조절할 수 없는 인자와 생활습관과 같은 조절할 수 있는 위험 요인으로 나눌 수 있습니다.

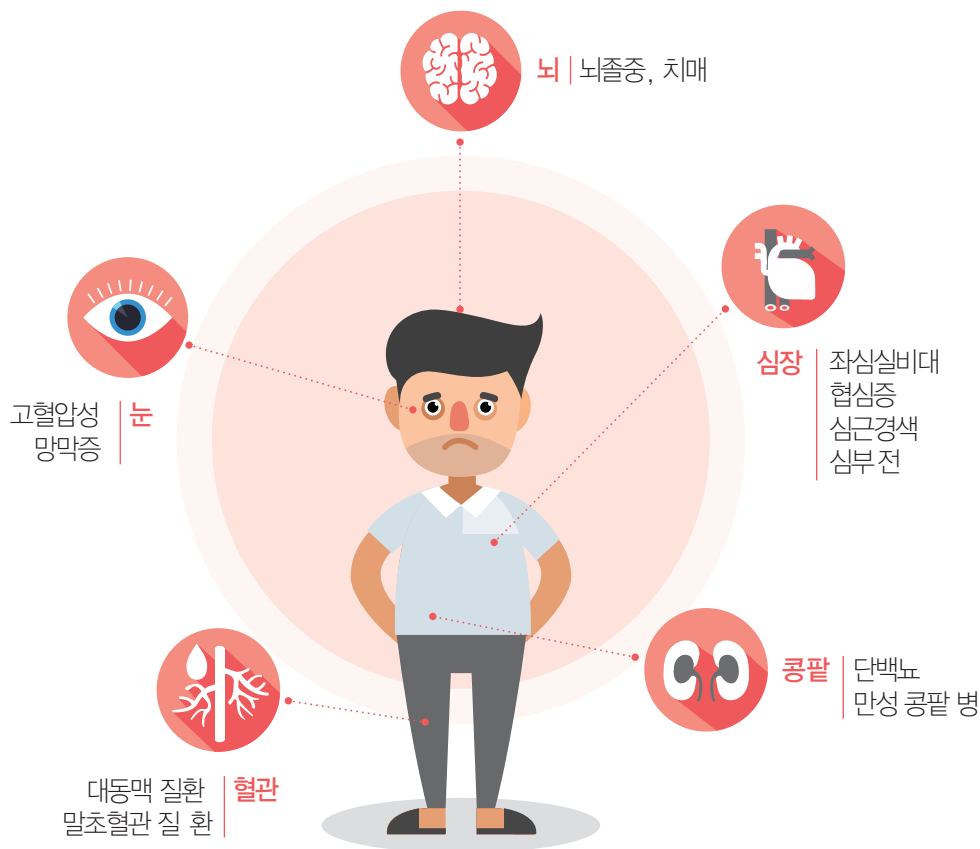
이차성 고혈압

드물게 특별한 원인 질환 때문에 발생하는 고혈압을 말합니다. 이차성 고혈압은 수술 및 약물로 완치가 가능한 경우가 있으므로 조기 진단이 중요합니다.

고혈압의 위험 요인

위험 요인 항목	내용
성별	남성
연령	남성 55세 이상, 여성 65세 이상
조기 심혈관 질환의 가족력	부모·형제·자매 중 남성 55세 미만, 여성 65세 미만에 발생한 심혈관 질환
건강 행태	흡연
이상지질혈증	총 콜레스테롤 230 mg/dL 이상 저밀도지질단백(LDL)-콜레스테롤 150 mg/dL 이상 고밀도지질단백(HDL)-콜레스테롤 40 mg/dL 미만 중성지방 200 mg/dL 이상
공복 혈당	100 mg/dL 이상
체질량지수	25 kg/m ² 이상
복부 비만	남성 90 cm 이상, 여성 85 cm 이상

고혈압의 증상과 합병증



고혈압은 일반적으로 뚜렷한 증상이 없어 많은 환자들이 질환을 인식하지 못하고 진단이 되더라도 적절한 치료를 받지 않는 경우가 많습니다. 또한 고혈압 환자의 절반 이상은 심혈관 질환 위험 요인을 가지고 있으며, 적절한 치료를 받지 않으면 우리나라 주요 사망원인인 심근경색이나 뇌졸중과 같은 합병증이 발생할 수 있습니다.

고혈압 조절의 궁극적 목표는 혈압의 감소가 아닌 심혈관 질환의 예방이므로 고혈압 환자는 동반된 위험 요인을 확인함과 동시에 조절해야 하며, 고혈압에 의해 뇌졸중, 심혈관 질환 등 장기 손상이 발생하였는지를 확인하기 위한 검사를 해야 합니다.

04 고혈압의 진단과 조절 목표

고혈압의 진단 기준

고혈압은 수축기 혈압이 140 mmHg 이상 또는 이완기 혈압이 90 mmHg 이상일 때로 정의됩니다. 반면, 정상 혈압은 수축기 혈압과 이완기 혈압 모두 120 mmHg와 80 mmHg 미만일 때로 정의됩니다. 특히 2기 고혈압 전 단계는 향후 고혈압으로 발전할 가능성이 높아 적극적인 예방이 필요합니다.

고혈압의 진단 기준

(단위: mmHg)

혈압 분류		수축기 혈압		이완기 혈압
정상 혈압*		<120	그리고	< 80
고혈압 전 단계	1기	120~129	또는	80~84
	2기	130~139	또는	85~89
고혈압	1기	140~159	또는	90~99
	2기	≥160	또는	≥90
수축기 단독 고혈압		≥140	그리고	< 90

* 심혈관 질환의 발병 위험이 가장 낮은 최적 혈압

— 출처: 대한고혈압학회, 고혈압 진료지침, 2013

고혈압 치료의 목표 혈압

치료 대상	목표 혈압
일반적 치료 목표	· 140/90 mmHg 미만
노인성 고혈압 환자	· 우선적으로 수축기 혈압 150 mmHg 미만 (혈압 조절에 따른 불편함이 없는 경우 일반 성인과 마찬가지로 140 mmHg 이하) · 80세 미만은 140/90 mmHg 미만 · 80세 이상은 150/90 mmHg 미만
임신성 고혈압 환자	· 150/100 mmHg 미만
당뇨병 동반 환자	· 140/90 mmHg 미만
심뇌혈관, 관상동맥 질환 동반 환자	· 130/80 mmHg 미만
만성 콩팥병 환자	· 140/90 mmHg 미만 (단백뇨가 있는 경우는 130/80 mmHg 미만)

자주하는 질문

Q

증상이 없는데 왜 고혈압 치료를 하고 약을 먹어야 하나요?

A

고혈압은 증상이 없는 경우가 많아 환자들이 치료의 중요성을 간과하기 쉽습니다. 특히 30~40대의 젊은 연령층의 경우 고혈압 치료를 잘 받지 않거나 심지어 본인이 고혈압이 있는지도 모르는 경우가 많습니다. 고혈압을 치료하는 이유는 증상을 치료하기 위해서라기보다는 고혈압으로 인한 합병증을 최소화하기 위해서입니다. 고혈압을 앓고 있는 사람은 고혈압의 치명적 합병증인 뇌졸중 및 관상동맥 질환의 위험이 정상인에 비해 2.5배 이상 높는데, 고혈압을 치료하게 되면 이러한 합병증을 줄일 수 있습니다. 젊은 나이에 이러한 합병증이 발생하게 되면, 개인과 가족 뿐만 아니라 사회 경제적으로 피해가 크고 장애 등의 후유증이 오래 지속 되므로 주기적인 검진과 적절한 치료가 꼭 필요합니다.

Q

고혈압의 증상은 무엇인가요? 고혈압이 있으면 목이 뻣뻣한가요?

A

우리는 흔히 목 뻣뻣하거나 두통이 잦으면 고혈압이라고 생각하는 경우가 많은데, 목 뻣뻣한 것은 대부분 긴장성 두통 때문입니다. 혈압으로 인한 두통은 혈압이 매우 높아져 그로 인해 뇌압이 올라갈 때에만 가능하므로 대부분의 고혈압은 두통을 유발하지 않습니다. 일부에서는 코피가 자주 나면 고혈압이라는 이야기도 있지만 이것 또한 사실이 아닙니다. 어지럼증, 두근거림, 피로, 성기능 장애 등이 혈압 상승과 관련이 있을 수 있지만 이런 증상들은 일상적인 상황 또는 다른 질병에 의해서도 발생할 수 있기 때문에 고혈압의 특징적인 증상이라고 볼 수는 없습니다.

Q

혈압약을 계속 먹으면 신장 기능이 나빠진다는데 사실인가요?

A

혈압약을 복용하면 신장이 나빠진다고 오해하는 환자들이 있는데 이것은 매우 잘못된 상식입니다. 오히려 신부전이나 당뇨가 있는 고혈압 환자가 적극적인 고혈압 치료를 받음으로써 신장 기능을 오랫동안 보전할 수 있습니다.

자주하는 질문

Q

혈압약을 먹으면 정력이 감퇴되나요?

A

성기에 동맥경화가 진행된 경우 고혈압 치료로 혈압이 낮아지면 일시적으로 발기 기능이 떨어질 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 낮아진 혈압에 적응되면 발기 기능은 회복됩니다. 발기 부전이 지속된다면 이는 신체 상태가 심혈관 질환의 발생 위험성이 높은 경우이기 때문에 고혈압 치료를 유지하며 발기 부전 치료제를 사용하는 것이 올바른 대처 방법입니다. 한편 발기 부전을 예방하거나 치료하는 데에는 금연, 절주, 적당한 운동이 중요합니다.

Q

노인도 고혈압 치료를 받아야 하나요?

A

노인은 고혈압을 치료할 필요가 없다고 생각할 수 있는데, 실제로는 노인에게 고혈압의 합병증인 뇌졸중, 심장병이 발생하는 경우가 많습니다. 고혈압 치료를 하면 합병증이 젊은 사람은 30% 감소하고 노인은 15% 감소하지만 노인의 합병증 빈도가 훨씬 높기 때문에 합병증의 절대 감소치는 노인이 훨씬 큼니다. 또한 혈압을 조절하면 노인의 인지 기능 저하를 막고 치매 발생을 줄이거나 지연시킬 수 있으므로 적절한 고혈압 치료를 받는 것이 중요합니다.

Q

고혈압의 원인은 유전인가요? 생활 습관 개선으로 예방할 수 있나요?

A

고혈압은 유전적인 특성이 강한데, 부모가 모두 고혈압이면 자식이 고혈압에 걸릴 확률은 약 80% 정도이며, 이때 나쁜 생활 습관 등 환경적인 요인이 겹치면 고혈압이 더 잘 발생하게 됩니다. 고혈압은 마른 사람에게도 발생할 수 있지만, 대개 뚱뚱한 사람들에게 많은데 몸무게(kg)를 키(m)의 제곱으로 나눈 체질량 지수가 1이 증가하면 고혈압의 유병률은 12% 증가합니다. 고혈압의 가족력이 있다 하더라도 생활 습관을 개선하면 고혈압의 발생을 줄일 수 있는데, 비약물 치료 중에서는 체중 감소가 효과적이며 저염식, 절주, 운동, 금연을 하는 것도 고혈압 예방에 좋은 방법입니다.

고 혈 압
예 방 과 관 리
7대 생활 수칙



01 👍👍👍
음식을 싱겁게 먹습니다



02 👍👍👍
적정 체중과 허리둘레를 유지합니다



03 👍
과일과 채소를 섭취합니다



04 👍👍👍
규칙적으로 운동합니다



05 👍👍👍
금연합니다



06 👍
절주합니다



07 👍👍👍
정기적으로 혈압을 측정하고 검진합니다

근거 수준 👍 낮음 👍👍 보통 👍👍👍 높음

이 생활 수칙을 도출하기 위해 참고한 국내외 학술지에 게재된 논문 등의 연구 설계 방법에 따라 근거 수준을 높음, 보통, 낮음으로 표기하였습니다.

[참고]

높음: 체계적 문헌 고찰, 대조군이 있는 임상 연구

보통: 코호트 연구, 환자-대조군 연구

낮음: 대조군이 없는 단면 연구, 전문가 의견

01

첫째, 싱겁게 먹습니다

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 소금의 1일 권장 섭취량을 압니다.
- 싱겁게 먹는 방법을 알고, 항상 실천합니다.
- 내가 얼마나 짜게 먹고 있는지 확인합니다.
- 저염식 반찬 만드는 방법을 배우고, 배운 대로 조리를 합니다.



관련 상식 들여다보기

- 한국인은 하루 평균 약 10 g(나트륨 4 g, 2014년 국민건강영양조사)의 소금을 섭취하며, 권장 섭취량인 6 g 보다 높습니다.
- 고혈압 환자가 저염식의 균형 잡힌 식사를 하면 혈압이 떨어지고 심혈관 합병증이 예방됩니다.
- 하루 소금 섭취량을 권장량으로 줄이면 수축기 혈압은 평균 5.1 mmHg, 이완기 혈압은 2.7 mmHg 감소합니다.
- 소금 섭취에 따른 혈압 상승 정도를 소금에 대한 감수성이라고 하는데, 고령자, 비만자, 당뇨병 또는 고혈압의 가족력이 있는 사람이 더욱 높습니다. 소금에 대한 감수성이 높을수록 적극적인 저염식을 할 때 혈압이 더 효과적으로 낮아집니다.

실천 방법 알기

소금의 1일 권장 섭취량을 압니다.

- ▶ 싱겁게 먹으면 혈압을 낮출 수 있습니다.
- ▶ 소금의 1일 권장 섭취량
 - 하루 소금 섭취는 1 티스푼 정도인 6g 정도를 권장합니다.

TIP

나트륨
함량(g)

× 2.5 =

소금의
함량(g)

싱겁게 먹는 방법을 알고, 항상 실천합니다.

- ▶ 국물은 적게 먹습니다.
- ▶ 밥을 국에 말아 먹지 않고 따로 섭취합니다.
- ▶ 음식을 먹을 때 추가로 소금이나 간장을 넣지 않습니다.
- ▶ 김치, 젓갈, 장아찌와 같은 음식은 적게 먹습니다.
- ▶ 반찬 가게에서 짜게 조리된 국과 반찬을 사서 먹지 않습니다.
- ▶ 가공적 외식을 줄이고, 자연 재료로 조리된 음식을 먹습니다.

내가 얼마나 짜게 먹고 있는지 확인합니다.

- ▶ 가까운 고혈압 등록·관리 교육센터 및 보건소에서 ‘나트륨 섭취’에 대한 교육 여부를 확인하고 교육을 받습니다.
- ▶ 염도기로 내가 먹고 있는 국과 반찬의 염도를 재보고, 싱겁게 먹고 있는지 확인합니다.

저염식 반찬 만드는 방법을 배우고, 배운 대로 조리를 합니다.

- ▶ 지역사회에서 제공하는 저염식 요리 교육에 참여하고, 특히 저염 김치 만드는 방법을 배웁니다.

TIP

- 조리할 때 소금, 간장, 된장, 고추장 등을 적게 넣습니다.
- 음식의 맛을 낼 때 나물, 채소, 과일 또는 소금 없는 조미료를 사용합니다.
- 식탁에서 소금과 간장을 치우고 음식에 더 넣지 않습니다.
- 절인 식품의 섭취량과 횟수를 줄입니다.

자주하는 질문

Q

싱겁게 조리하면 많이 먹어도 되나요?

A

싱겁게 먹더라도 음식을 많이 먹게 되면 결국 소금 섭취는 증가하므로 많이 섭취하는 것은 좋지 않습니다. 특히 국물을 많이 먹는다면 줄이는 것이 좋습니다.

Q

외식 시 올바른 식사 주문 방법은 무엇인가요?

A

일반적으로 외식은 맛있게 만들기 위해 여러 가지 양념을 많이 사용하므로 집에서 만든 음식에 비해 열량, 지방과 염분 함량이 높습니다. 또한 영양소가 골고루 함유되지 않은 경우가 많아 외식을 하는 경우 영양 섭취가 불균형해지기 쉽습니다.

TIP

외식 시의 올바른 식사 주문 방법

- ① 다양한 재료로 만든 메뉴를 선택합니다. 특히 신선한 채소를 충분히 먹을 수 있는 메뉴를 고릅니다.
- ② 어떤 음식을 먹을 것인지 미리 생각해서, 총동적으로 많은 음식을 주문하지 않도록 합니다.
- ③ 튀김이나 부침류보다는 구이, 찜 요리를 선택합니다.
- ④ 계획한 식사량만큼 먹습니다. 많은 양이 나온 경우, 먹을 분량만 덜어서 먹도록 합니다.
- ⑤ 뷔페 식당을 이용할 때는 특히 과식하지 않도록 조심합니다.
- ⑥ 달고 기름진 음식이나 소금이 많은 탕류보다는 반찬을 골고루 먹을 수 있는 음식이 좋습니다. 한식은 여러 가지 음식을 골고루 먹을 수 있지만 소금 섭취가 많을 수 있으므로 주의합니다.
- ⑦ 국물이 있는 음식의 경우 국물을 남기고 건더기를 위주로 먹습니다.
- ⑧ 잘 모르는 음식을 주문할 때는 주문 전에 음식 재료 및 조리 방법을 확인합니다.

자주하는 질문

짜게 먹으면 혈압이 높아지나요? 싱겁게 먹는 게 고혈압 치료에 도움이 되나요?

염분에 따른 혈압 상승 정도는 사람마다 다르나, 일반적으로 짜게 먹을수록 혈압이 증가하고 소금 섭취를 줄이면 혈압이 감소하게 됩니다. 소금 섭취량을 제한하면 혈압이 낮아지므로 의식적으로 줄일 필요가 있습니다.

MEMO

02

둘째, 적정 체중과 허리둘레를 유지합니다

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 정기적으로 체중과 허리둘레를 확인하고, 적정 몸무게를 유지합니다.
- 식사를 조절하고 신체 활동량을 늘려 적정 체중을 유지합니다.



관련 상식 들여다보기

- 체중과 혈압은 관계가 매우 밀접하므로 식사 조절과 신체 활동 늘리기 등을 통해 체중을 감량하면 당뇨병, 이상지질혈증, 좌심실비대가 있는 환자에게 도움이 됩니다.
- 체중이 정상보다 무거우면 고혈압이 발생할 확률이 정상의 2~6배까지 증가합니다.
- 복부 비만은 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병 및 관상동맥 질환 사망률과 매우 밀접한 관련이 있습니다.
- 고혈압 환자가 체중 1 kg을 줄이면 수축기/이완기 혈압은 1.1/0.9 mmHg가 감소됩니다.
- 식사 조절과 신체 활동 늘리기를 동시에 병행해야 체중을 조절할 수 있고, 줄인 체중을 오래 유지할 수 있습니다.

실천 방법 알기

정기적으로 체중과 허리둘레를 확인하고,
적정 몸무게를 유지합니다.

- ▶ 자신의 표준체중을 정확히 알고 유지합니다.
 - 남자의 표준체중(kg) = 키(m) × 키(m) × 22
 - 여자의 표준체중(kg) = 키(m) × 키(m) × 21
- ▶ 적정 체질량지수(BMI) 목표: 25 kg/m² 미만 유지
 - 체질량지수 = 체중(kg) ÷ [키(m) × 키(m)]
 - 25~30 kg/m² 이면 비만, 30 kg/m² 이상이면 고도비만
- ▶ 적정 허리둘레 목표
 - 남성 90 cm(35인치) 미만, 여성 85 cm(33인치) 미만 유지

식사를 조절하고 신체 활동량을 늘려 적정 체중을 유지합니다.

- ▶ 자신의 하루 필요 열량을 알고 과일과 채소를 포함한 균형 잡힌 식단을 생활화 합니다.
- ▶ 자신의 하루 필요 열량을 계산해 봅니다.
 - 육체활동이 거의 없는 경우: 표준체중(kg) × 25~30 칼로리
 - 보통의 활동을 하는 경우: 표준체중(kg) × 30~35 칼로리
 - 심한 육체활동을 하는 경우: 표준체중(kg) × 35~40 칼로리예시) 키가 165 cm (1.65 m)인 남자가 사무직 일을 한다면, 표준체중은 $1.65 \times 1.65 \times 22 = 60$ kg이고, 하루 필요 총열량은 $60 \times 30 \sim 35 = 1800 \sim 2100$ 칼로리입니다. 체중감량이 필요한 경우에는 위에서 계산한 하루 필요 열량에서 300~500 칼로리를 줄입니다.

TIP 체중 감량 및 유지에 필요한 식사 요법

- 거르지 않고 천천히 먹습니다.
- 당분이 많은 음식이나 술 등은 피합니다.
- 빵, 과자, 청량음료 등 불필요한 간식을 먹지 않아야 합니다.
- 섬유소가 많은 채소, 적당한 과일은 매일 섭취합니다.
- 기름이 많은 음식이나 기름을 많이 사용해서 조리한 음식을 피합니다.
- 생선은 최소 주 2회 섭취하고, 콜레스테롤과 포화지방산을 적게 섭취하도록 합니다.

실천 방법 알기

▶ 신체 활동을 늘리는 요령

- 규칙적인 운동이 어려운 경우 매일매일 일상생활 속에서 신체 활동량을 조금씩 늘려 갑니다.
- 가까운 거리는 걸어서 이동합니다. 가능하면 빠르게 걷기를 5~10분 정도 자주 반복합니다.
- 승강기를 타는 대신 계단을 이용해서 운동량을 조금이라도 늘립니다.
- 텔레비전을 보면서 한자리에 가만히 앉아 있지 않고 일어서서 가볍게 맨손체조를 하거나 의자에 앉은 자세로 스트레칭을 하는 습관을 가집니다.
- 운동 장비가 갖추어진 동네 휴식처에 매일 30분씩 가서 신체 활동량을 늘립니다. 근처에 무료로 운영하는 운동 프로그램이 있을 경우 빠지지 않고 열심히 참여합니다.

▶ 지역사회 혹은 보건소에서 제공하는 교육 프로그램에 열심히 참여합니다.

▶ 과체중이 심각하거나 허리둘레 치수가 큰 경우 병·의원을 방문해서 의사에게 식사와 운동에 대한 전문적인 상담을 받고, 권고 내용대로 꾸준히 관리합니다.

자주하는 질문

Q 고혈압과 비만은 어떤 관계가 있나요?

- A 고혈압은 체중과 밀접한 관계가 있고, 살이 찌서 체중이 늘면 혈압이 올라갑니다. 반대로 체중을 줄이면 혈압이 낮아집니다. 더욱 중요한 것은 고혈압이 있을 때 당뇨병과 이상지질혈증의 발생 빈도가 높아진다는 것입니다. 고혈압 환자가 표준체중을 10% 이상 초과하는 경우, 5 kg 정도의 체중을 줄이면 뚜렷한 혈압 감소 효과를 얻을 수 있는데, 체중 1 kg을 줄이면 수축기/이완기 혈압은 1.1/0.9 mmHg가 감소됩니다.

Q 김치를 많이 먹는 것이 채소 섭취를 늘리는 것인가요?

- A 김치는 소금에 절여 양념을 한 식품으로 나트륨 성분이 많이 포함되어 있어 섭취량을 주의 해야 합니다. 하루에 너무 많은 양의 김치를 먹는 것은 바람직하지 못하며 그보다는 칼륨 성분이 많이 든 채소를 많이 먹는 것이 좋습니다.

03

셋째 과일과 채소를 섭취합니다

실천 항목

낮은 근거 👍

- 고혈압 예방을 위한 식사법을 알고 실천합니다.
- 혈압을 낮추는 식단을 알고, 필요할 경우 적절히 활용합니다.



관련 상식 들여다보기

- 채식주의자들은 육식을 주로 하는 사람들보다 혈압이 낮으며, 고혈압 환자도 채식 위주의 식사를 유지하면 혈압이 낮아집니다. 이런 효과는 단백질을 섭취하지 않아서라기보다는 과일, 채소, 섬유질의 섭취가 늘고 포화지방산 섭취가 줄었기 때문입니다.
- 고혈압 환자에게 혈압을 낮추기 위한 식사 요법인 DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension) 처럼 과일, 채소와 생선을 더 많이 섭취하고 지방을 적게 섭취하도록 권고합니다.
- 수축기 혈압/이완기 혈압이 120~159/80~95 mmHg인 경우 DASH 음식을 섭취하면 혈압을 5~6/3 mmHg 정도 낮출 수 있습니다.
- 당뇨병이 있고 3개 이상의 심혈관 위험 인자가 있는 환자가 지중해식으로 음식을 섭취하면 혈압을 6~7/2~3 mmHg 낮출 수 있으며, 건강한 사람도 혈압을 2~3/1~2 mmHg 낮출 수 있습니다.
- 생선을 규칙적으로 섭취하면 비만인 고혈압 환자의 혈압은 더 크게 낮아지고 지질대사가 개선되는 효과가 나타납니다.

실천 방법 알기

고혈압 예방을 위한 식사법을 알고, 실천합니다.

- ▶ 신선한 과일과 채소를 매일 충분히 먹습니다.
- ▶ 저지방 유제품, 전곡, 가금, 생선, 견과류 등을 많이 먹습니다.
- ▶ 설탕 등 단순 당의 섭취를 줄입니다.
- ▶ 포화지방산 및 총 지방 섭취량을 줄입니다.
- ▶ 감미료나 설탕이 함유된 음료, 붉은 고기 등을 적게 먹습니다.

혈압을 낮추는 식단을 알고, 필요할 경우 적절히 활용합니다.

- ▶ 고혈압을 낮추기 위한 DASH 식사 요법 식습관을 가집니다.

DASH(Dietary Approaches to stop hypertension)란 고혈압 치료를 위한 식사 요법 중의 하나로 음식 중 포화지방, 콜레스테롤, 총 지방 함량은 줄이고 칼륨, 마그네슘, 칼슘, 단백질, 섬유소 함량은 늘릴 수 있는 식사 요법입니다.

- ▶ 고혈압을 낮추기 위한 DASH 식사 요법
 - 포화지방산 및 콜레스테롤, 지방 등의 총량을 줄입니다.
 - 과일, 채소, 저지방 유제품 섭취를 늘립니다.
 - 전곡류를 통하여 식이섬유 섭취를 늘립니다.
 - 소금은 1일 6 g 이하로 줄입니다.
 - 간식 및 설탕이 함유된 식품 섭취를 줄입니다.
- ▶ 지중해식 식단을 유지하며, 최소 주 2회는 생선을 먹습니다.
 - 신선한 과일, 녹색채소, 전곡, 오메가-3-지방산이 풍부한 기름진 생선 섭취를 늘립니다.
 - 저지방 또는 무지방 유제품, 견과류, 올리브 또는 카놀라 오일, 평지씨, 나아마씨로 만든 마가린 등을 섭취합니다.
 - 붉은 고기 섭취는 줄입니다.

넷째, 규칙적으로 운동을 합니다

04

실천 항목

높은 근거 🍌🍌🍌

- 운동은 요령을 알고 규칙적으로 실천합니다.
- 규칙적인 신체 활동(유산소 및 무산소운동)으로 혈압을 낮춥니다.



관련 상식 들여다보기

- 규칙적으로 운동을 하면 혈압이 낮아지고, 심폐 기능이 개선됩니다. 또한 체중이 줄고 이상지질혈증도 개선되며 스트레스도 해소될 수 있습니다.
- 아령 들기와 같은 동적 저항 운동도 권유하지만 무거운 기구를 들어 올리는 운동은 일시적으로 혈압을 상승시킬 수 있으므로 혈압이 잘 조절되지 않는 경우 피해야 합니다.
- 대부분의 고혈압 환자는 운동 전에 특별한 검사가 필요 없지만, 심장병이 있는 환자는 운동부하검사 등의 정밀 검사가 필요할 수 있으므로 전문의와 상의해야 합니다.

실천 방법 알기

운동은 요령을 알고 규칙적으로 실천합니다.

- ▶ 대근육을 율동적으로 움직이는 유산소운동(걷기, 뛰기, 자전거 타기, 수영 등)을 합니다.
 - 중강도(숨이 약간 찬 느낌이 있으나, 말을 할 수 있는 정도)의 유산소운동을 한 번에 30분 이상, 일주일에 5~7일, 최소 3일 이상 실시합니다.
 - 운동의 강도는 최대 심박 수(220-연령)의 60~80%가 바람직합니다.
 - 처음 시작할 때는 10~20분 정도 하다가 천천히 연장하여 30~60분 정도를 지속하는 것이 좋으며, 준비 운동과 마무리 운동을 운동 전후에 5분 정도 하는 것이 좋습니다.
- ▶ 유산소운동과 함께 동적 저항 운동(힘을 쓰면서 움직이는 운동)을 일주일에 2~3일 정도 실시합니다.
- ▶ 심장병이 있거나 위험 인자가 있는 환자는 운동 시작 전에 전문의와 상의합니다.
- ▶ 기온이 떨어지면 혈관이 수축하여 혈압이 오르게 되므로 새벽이나 추운날을 피하여 실내에서 운동합니다.

규칙적인 신체 활동(유산소 및 무산소운동)으로 혈압을 낮춥니다.

- ▶ 유산소운동을 규칙적으로 하면 혈압이 낮아집니다.
 - 유산소운동을 규칙적으로 하면 고혈압 환자의 수축기 혈압이 6.9 mmHg, 이완기 혈압이 4.9 mmHg 낮아집니다.
 - 저강도의 규칙적인 신체 활동도 사망률을 20% 낮춥니다.
- ▶ 무산소운동을 규칙적으로 하면 혈압이 낮아집니다.
 - 동적 저항 운동(힘을 쓰면서 움직이는 운동)도 혈압 감소와 함께 대사 기능을 호전시킵니다. 무거운 기구를 들어 올리는 운동은 일시적으로 혈압을 상승시킬 수 있으므로 유산소운동으로 몸이 충분히 이완된 상태에서 하는 것이 좋습니다.

자주하는 질문

Q

운동을 마친 후에 혈압이 더 올라갑니다. 왜 그렇습니까?

A

일어선 상태에서 운동을 할 때 정상적으로는 수축기 혈압은 점진적으로 높아지고 이완기 혈압은 약간 낮아집니다. 혈압의 정상적인 반응은, 운동 후 20~50분이 지나면 점차 감소하는 양상을 보이므로 운동 직후에 혈압을 측정하지 말고 충분히 휴식을 취한 뒤에 측정해야 합니다. 혈압을 측정할 때 맥박을 같이 측정해 맥박이 60~80회 범위로 안정된 경우의 혈압을 기록합니다.

Q

잠자기 몇 시간 전에 운동을 마치는 것이 좋습니까?

A

운동 강도에 따라 그 기준은 다르나 잠들기 1~3시간 전에 운동을 끝내는 것이 좋습니다.

Q

어느 강도로 어떤 운동을 하는 것이 좋을까요?

A

최대 맥박 수는 연령마다 정해져 있습니다. 운동을 지치도록 하는 것이 아니라 연령마다 정해져 있는 최대 맥박수의 80% 정도의 강도로 가능한 한 매일(1주일에 최소 3회 이상) 규칙적으로 꾸준히 하는 것이 좋습니다. 고혈압 환자에게 적합한 운동은 체력 증진을 목적으로 하루 200칼로리 내외를 소비하는 신체 활동입니다. 비슷한 강도의 운동으로는 수영 23분, 달리기/조깅 23분, 테니스 27분, 골프/걷기 35분, 자전거 타기 45분 등이 있습니다.

05

다섯째, 금연합니다

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 완전한 금연을 목표로 합니다.
- 나에게 맞는 금연 방법을 선택합니다.
- 금연 성공 후에도 지속적으로 관리를 합니다.



관련 상식 들여다보기

- 흡연 할 때에는 담배에 들어있는 니코틴에 의하여 일시적으로 혈압과 맥박이 높아집니다.
- 흡연은 고혈압과 마찬가지로 심혈관 질환의 강력한 위험 요인이기 때문에 고혈압 환자가 아무리 혈압을 잘 조절한다고 하더라도 담배를 계속 피운다면 심혈관 질환의 위험을 피할 수 없습니다.
- 흡연은 암이나 만성 폐 질환뿐만 아니라 뇌경색증, 심근경색증, 말초동맥 질환 등의 원인이 되는데, 고혈압 환자가 흡연을 하는 경우 더 심각하고 빠르게 이러한 질환이 유발되고 악화됩니다.

완전한 금연을 목표로 합니다.

- ▶ 전문가와 상담을 합니다.
 - 흡연 중인 모든 고혈압 환자는 의사에게 고혈압 합병증 예방을 위해 흡연 여부, 금연 의지, 니코틴 중독 정도 등에 대한 상담과 처방을 받아야 합니다.

나에게 맞는 금연 방법을 선택합니다.

- ▶ 니코틴 의존도, 흡연 습관, 스트레스 평가 등의 자가진단을 통해 자신에게 알맞은 금연 방법을 선택합니다.
- ▶ 금연을 위한 금연 계획 방법(STAR)
 - ① Setting a quit day: 나의 금연동기와 이유를 확인하고 금연시작일 정하기
 - ② Tell family, friends about quitting: 자신의 금연을 주위에 알리기
 - ③ Anticipate challenge to quit attempt: 계획된 금연 시도에서 나타날 장애 요인 파악하기
 - ④ Remove tobacco product: 담배와 담배 관련 물건 정리하기

금연 성공 후에도 지속적으로 관리 합니다.

- ▶ 운동 및 식사 요법을 병행합니다.
 - 금연 후에는 체중이 늘 수 있으므로 이를 방지하기 위해 운동 및 식사 요법과 병행하여야 합니다.
 - 각 지역 보건소와 병원의 금연클리닉을 방문하거나 방문이 어려운 상황일 경우, 금연상담전화(1544-9030) 또는 금연길라잡이 인터넷 누리집(<http://www.nosmokeguide.or.kr>) 등의 서비스를 이용하여 도움을 받는 것도 좋습니다.

TIP

상황에 따른 흡연 욕구 다스리기

- **다른 사람들의 흡연:** 잠시 흡연자를 피하기, 음식점에서 금연 구역에 앉기, 흡연을 하는 친구들에게 현재 금연 중임을 알리기
 - **술자리:** 과음과 과식은 금물, 맵고 짠 자극적인 음식은 흡연 욕구를 일으킬 수 있으니 주의하고 물을 많이 마시며 술자리를 함께 하는 사람들에게 금연 중임을 반드시 알리기
 - **커피:** 카페인 대신 음료 대신 주스나 물 마시기
 - **아침에 일어나서 흡연 욕구를 느낄 때:** 아침에 일어나서 첫 번째로 하는 일을 흡연에서 다른 것으로 대체하기(일어나자마자 물을 한 잔 마시고 양치하기, 산책 또는 샤워하기)
 - **식사 후:** 식후 즉시 테이블에서 일어나기, 식후 바로 양치를 하거나, 친구에게 전화 걸기
 - **문득 담배가 매우 피우고 싶을 때:** 흡연 욕구는 3~5분 이내에 사라지므로 때문에 흡연에 대한 욕구가 없어질 때까지 잠시 하던 일을 멈추고 담배 생각이 안 나도록 다른 행동하기(간식 먹기, 물 마시기, 음악듣기, 계단 오르내리기, 가벼운 스트레칭, 심호흡, 가족이나 친구에게 전화하거나 메신저 보내기)
 - **스트레스:** 흡연이 스트레스를 해소 해준다는 잘못된 생각을 버리고 스트레스 원인을 없애거나, 대처 방법을 바꾸기(심호흡, 명상 또는 요가를 통해 스트레스 대처)
- * 446호흡법: 4초 동안 숨을 들이마시고 4초 동안 숨을 참다 마지막 참았던 숨을 6초 동안 길게 내쉬기

06

여섯째, 절주합니다

실천 항목

낮은 근거 

- 적절한 음주량을 알고, 절주를 실천합니다.



관련 상식 들여다보기

- 체중이 가벼운 사람은 소량의 알코올 섭취에도 영향이 크기 때문에 일반인의 적정 음주량보다 더 적게 마셔야 하며, 과음 시 뇌졸중의 위험이 높아지므로 주의해야 합니다.
- 고혈압 환자의 경우 과도하게 술을 마시면 혈압이 상승하고 고혈압 약에 대한 저항성이 커져서 약의 효과가 줄어듭니다.
- 하루 적정 음주량은 일반적으로 남자의 경우 해당 주류 잔의 2잔 이하, 여성은 1잔 이하입니다.

실천 방법 알기

적절한 음주량을 알고, 절주를 실천합니다.

- ▶ 적절한 음주량은 알코올 양을 기준으로 남성은 하루 20~30 g(소주 2~3잔) 이하, 여자는 하루 10~20 g(소주 1~2잔) 이하입니다.

TIP · 알코올 30 g은 소주 2~3잔(1/3병), 맥주 720 mL(1병), 와인 200~300 mL(1잔), 정종 200 mL(1잔), 위스키 60 mL(2샷) 등에 해당합니다.
· 1주일 총 알코올 음주량은 남성은 140 g, 여성은 80 g 미만이 좋습니다.

자주하는 질문

Q 알코올은 혈압에 어떤 영향을 주나요?

A 알코올이 혈압을 상승시키는 원인에 대해서는 아직 정확히 밝혀진 바가 없습니다. 다만, 알코올이 심장을 흥분시키고 혈관을 수축시키는 호르몬인 아드레날린의 분비를 촉진한다고 알려져 있습니다. 술을 마시면 처음에는 얼굴이 붉어지는 것처럼 온몸의 혈관이 확장되어 혈압이 낮아지지만, 음주 후 알코올이 몸에서 제거되면서 반동 작용으로 혈압이 음주 전에 비해 더 많이 올라갑니다. 음주 후 새벽에 뇌졸중 위험이 높아지는 것은 이러한 혈압의 반동 상승과 연관되어 있을 것으로 생각됩니다. 실험에 따르면 과음하던 사람이 음주량을 적당량으로 줄이면 수축기 혈압이 평균 5 mmHg, 이완기 혈압이 평균 3 mmHg 떨어진다고 합니다. 또한 절주와 식사 요법을 함께 시행한다면 더 큰 혈압 조절 효과를 볼 수 있습니다.

Q 혈압약을 복용 중인데 술을 마셔도 되나요?

A 적당량의 음주는 괜찮다고 하지만 혈압약을 복용하고 있다면 금주하는 것이 좋습니다. 하루 한 잔 정도의 음주는 혈압에 큰 영향을 주지 않지만, 우리 사회의 음주 문화가 여럿이 어울려 한자리에서 많이 마시는 문화이기 때문에 주의가 필요합니다. 포도주 역시 과음 시에는 혈압에 나쁜 영향을 주는 것으로 알려져 있습니다. 특히 혈압약 중에는 혈관을 확장시켜 혈압을 낮추는 약들이 있는데 이것들이 술과 상승 작용을 일으켜 음주 직후의 혈압을 과도하게 낮추어 실신 등을 일으킬 우려가 있습니다.

07

일곱째, 정기적으로 혈압을 측정하고 검진합니다

실천 항목

높은 근거 👍 👍 👍

- 혈압 측정 방법을 알고, 건강한 사람도 정기적으로 혈압을 측정합니다.
- 고혈압 전 단계인 경우에는 매년 정기적으로 검진을 받습니다.



관련 상식 들여다보기

- 혈압은 혈액이 혈관 속을 흐르면서 혈관 벽에 미치는 압력을 말합니다. 보통 혈압이라 하면 동맥 내 혈압을 뜻합니다.
- 정상 혈압은 수축기 혈압 120 mmHg 이하, 이완기 혈압 80 mmHg 이하를 말합니다.
- 혈압이 높아지면 심장혈관 질환, 뇌졸중, 만성 콩팥병, 심부전, 망막증의 발생 위험과 사망률을 높입니다. 정기적인 혈압 측정은 고혈압을 조기에 발견하고 치료하여 합병증 발생과 사망률을 낮춥니다.

실천 방법 알기

혈압 측정 방법을 알고, 건강한 사람도 정기적으로 혈압을 측정합니다.

- ▶ 안정을 취한 후 혈압을 측정합니다.
 - 혈압은 하루 종일, 상황에 따라 변할 수 있습니다.
 - 3~5분 이상 가만히 앉아 쉰 상태에서 혈압을 측정합니다.
 - 집에서 혈압을 재는 경우에는 아침에는 자고 일어나서 1시간 이내에 소변을 본 후에 측정하고 저녁에는 잠자리에 들기 전에 측정합니다.
 - 식사 후 1시간, 운동 후 1~2시간이 지난 후에 측정합니다.
 - 흡연을 하거나 커피를 마신 후 30분~1시간이 지나 측정합니다.
 - 측정할 때마다 1~3회를 측정하여 평균 혈압을 측정합니다.
- ▶ 가정 혈압 측정법 알기
 - 위팔 혈압계의 사용을 고려합니다. 처음에는 양팔에서 측정하고 그 다음부터는 높은 쪽에서 측정합니다. 측정 당 1~3회 측정하여 평균값을 사용하며, 맥박 수를 같이 기입합니다.
 - **측정 시간** ① 아침: 자고 일어나 1시간 이내에 소변을 본 후 식탁에 앉은 자세에서 식사 전 최소 1~2분 안정 후 측정하며, 혈압약을 복용하지 않은 상태.
 - ② 저녁: 잠자리에 들기 전, 앉은 자세에서 최소 1~2분 안정 후
 - ③ 이 외 측정이 필요하다고 판단되는 경우
 - **측정 빈도**
측정당 1~3회를 측정하여 평균값을 사용하며, 맥박 수를 혈압과 같이 기입합니다.
- ▶ 건강한 사람도 정기적으로 혈압을 측정합니다.
 - 혈압은 나이가 들어감에 따라 높아집니다.
 - 50세 이상에서는 수축기 혈압이 합병증 예측에 더욱 중요합니다.

실천 방법 알기

고혈압 전 단계인 경우에는 매년 정기적으로 검진을 받습니다.

- ▶ 고혈압 전 단계는 수축기 혈압이 120~139 mmHg이거나, 이완기 혈압이 80~89 mmHg인 경우를 말합니다.
 - 정상 혈압보다 고혈압이 될 확률이 높습니다.
 - 당뇨, 이상지질혈증 등 다른 대사성증후군 발생 위험도 높습니다.
- ▶ 고혈압 전 단계인지 여부를 자주 확인하고, 특히 고혈압 전단계인 경우 매년 정기적으로 검진을 받습니다.

자주하는 질문

Q

당뇨병이 있는 사람은 어떤 주의가 필요한가요?

A

당뇨병 환자에게는 고혈압이 일반 인구 집단과 비교해서 2배 많이 발견되고, 고혈압 환자에도 당뇨병의 발생이 2.5배나 높습니다. 당뇨와 고혈압이 함께 있다면 심혈관 사망 위험이 크게 증가하기 때문에 고혈압을 잘 관리해야 합니다. 따라서, 두 질환을 동시에 가지고 있는 환자가 고혈압 치료를 받는다면 사망률 및 합병증 발생률을 일반 환자보다 더 큰 폭으로 줄일 수 있습니다. 당뇨병과 고혈압을 동시에 가지고 있는 경우 일반 고혈압 환자보다 좀 더 낮은 확장기 혈압을 목표로 설정하는 것이 일반적으로 도움이 되는데, 환자 상태나 동반 질환에 따라 치료 목표는 다르므로 전문가와 상담해야 합니다.

자주하는 질문

Q

왜 병원에 오기만 하면 혈압이 오르나요? 집에서 혈압을 측정해 보고 싶은데 어떻게 측정해야 하나요?

A

집에서 측정하는 혈압과 병원에서 측정하는 혈압이 다르다고(특히 병원에서 측정한 혈압이 훨씬 더 높다고) 느끼는 경우가 많습니다. 실제로 치료 중인 고혈압 환자의 20%는 병원에 오면 혈압이 높아지는 백의(白衣) 고혈압 환자라고 알려져 있으며, 이는 특히 노인에게 빈번하게 발견됩니다. 반대로 집에서는 혈압이 높게 측정되지만 진료실에서는 정상 혈압을 보이는 가면(假面) 고혈압 환자도 종종 있기 때문에 가정에서 혈압을 측정하는 것이 도움이 되기도 합니다. 집에서 혈압을 측정할 때는 아침에 일어난 후 1시간 이내, 밤에는 취침 전에 측정을 하는 것이 좋습니다. 시중에서 판매하는 전자 혈압계를 사용해도 좋으나 병원에서 측정하는 혈압과 차이가 너무 많이 난다면, 병원의 수은 혈압계와 비교하는 것이 좋습니다.

또한 최근 야간 고혈압, 아침 고혈압이 심혈관 질환의 위험 요인으로 밝혀졌으며, 하루 중 혈압의 변동 폭이 클수록 합병증이 많다는 연구 결과가 있습니다. 24시간 활동 혈압 측정은 일상생활을 하면서 혈압을 수시로 측정하는 것으로 하루 중의 혈압의 변동 폭을 볼 수 있어서 최근 각광받는 검사입니다.

측정 방법에 따른 고혈압의 진단 기준

혈압 측정법	수축기 혈압	이완기 혈압
진료실 혈압	≥ 140	≥ 90
24시간 활동 혈압		
· 일일 평균 혈압	≥ 130	≥ 80
· 주간 평균 혈압	≥ 135	≥ 85
· 야간 평균 혈압	≥ 120	≥ 70
가정 혈압	≥ 135	≥ 85



1. 개발 개요

개발자	2015 고혈압 임상진료지침 제정위원회 및 집필위원회
사용자	일반인 및 고혈압 환자
외부 검토	사용자 50명(일반인, 보건의료계 종사자, 개원의)
목적	근거를 기반으로 고혈압 예방·관리 수칙과 실천 방법 그리고 자주하는 질문에 대하여 꼭 필요한 정보를 제공함으로써 국민이 고혈압과 관련 위험 요인을 보다 쉽게 이해하고, 건강한 생활을 유지하는 것이 중요하다는 인식을 높이기 위함.
개발 영역	고혈압 소개, 고혈압에 관해 자주하는 질문, 고혈압 예방과 관리 7대 생활 수칙: 첫째, 음식을 싱겁게 먹습니다. 둘째, 적정 체중과 허리둘레를 유지합니다. 셋째, 과일과 채소를 섭취합니다. 넷째, 규칙적으로 운동을 합니다. 다섯째, 금연합니다. 여섯째, 절주합니다. 일곱째, 정기적으로 혈압을 측정하고 검진합니다.
예상 편익	장기적으로 심혈관 질환 발생 예방 및 감소, 고혈압 인지율 향상, 합병증 발생 예방 및 감소, 고혈압 환자의 치료 비용 감소

2. 개발 방법

- 의사용 진료지침(일차의료용 고혈압 임상진료지침 근거기반 권고요약본 2014) 과 같은 근거 자료(Same Evidence Body)를 사용하여 다학제 전문가들이 개발함.

3. 사용자 의견 조사 및 결과의 반영

- 의견 조사: 2015.12.14. ~ 12.21.
- 이 지침의 주 사용자인 일반인 50명(일반인, 보건의료계 종사자, 개원의)을 대상으로 「나와 가족을 위한 고혈압 예방과 관리 정보」의 필요도와 활용도에 대한 의견 조사를 수행함.

4. 편집의 독립성

- 재정 지원: 질병관리본부 만성질환관리과의 「만성질환 예방관리 가이드라인 개발 기술 지원」 사업의 하나로 2015년도 국민건강증진기금 민간경상보조 사업비를 지원받았으며, 재정 지원자가 이 진료지침의 내용이나 지침 개발 과정에 직접적인 혹은 잠재적인 영향을 주지 않음.
- 진료지침 개발에 참여한 모든 구성원들의 잠재적인 이해 상충 관계 유무를 확인하기 위하여 지난 2년 동안 지침 개발 내용과 관련된 주제로 1,000만 원 이상의 후원을 받거나, 사례금을 받고 자문에 응한 경우, 특정 기관 혹은 제약 회사의 지분 이익이나 스톡옵션과 같이 경제적 이익에 대한 권리를 제공받는 경우, 그리고 개발에 참여한 구성원이 특정 기관 혹은 제약회사에서 공식/비공식직 직함을 가지고 있는지의 여부까지, 자기기입식 조사표를 개발하여 조사한 결과 상충되는 혹은 잠재적인 이해관계가 없음.

5. 갱신의 원칙과 방법

- 새로운 약제, 치료법 등에 대한 양질의 근거가 명백한 경우에만 부분적으로 권고를 수정, 보완 혹은 삭제하는 방법으로 3~5년마다 의사용 진료지침을 갱신할 경우 같은 근거 자료를 사용하는 「나와 가족을 위한 고혈압 예방과 관리」 정보를 갱신할 예정임.

6. 관련 정보 찾아보기

- 일차 의료용 근거기반 디지털 가이드라인
- (www.digitalcpg.kr) 누리집에 접속



7. 집필진

· 고혈압 임상진료지침 제정위원회 2023

구분	추천 학회명	성명	소속	전문 과목
위원장	대한고혈압학회	김철호	분당 서울대병원	노인병(순환기) 내과
위원	대한심장학회	박성하	연세의료 세브란스병원	심장내과
위원	대한내과학회	최범순	가톨릭의대 서울성모병원	신장내과
위원	대한신장학회	장제현	가천의대 길병원	신장내과
위원	대한비만학회	김종화	부천 세종병원	내분비내과
위원	대한개원의협의회	박창해	인천은혜병원	가정의학과
간사	대한의학회	신인순	대한의학회 연구센터	보건학(방법론)

· 고혈압 임상진료지침 개정위원회 2023

추천 학회명	성명	소속	전문 과목
대한심장학회	박성하	연세의대 세브란스병원	심장내과
한국지질·동맥경화학회	이해영	서울대학교병원	순환기내과
대한고혈압학회	임상현	가톨릭의대 부천성모병원	순환기내과
대한내과학회	최범순	가톨릭의대 서울성모병원	신장내과
대한신장학회	장제현	가천의대 길병원	신장내과
대한비만학회	김종화	부천 세종병원	내분비내과
대한뇌졸중학회	박종무	을지의대 을지병원	신경과

· 대한의학회 임상진료지침 연구사업단 2023

구분	성명	소속
회장	정지태	대한의학회 회장, 고려대 병원
단장	이진우	대한의학회 부회장, 연세대 병원
부단장	용환석	대한의학회 정책이사, 고려대 병원
연구위원	신인순	대한의학회 연구센터 실장
연구원	김다솔	대한의학회 연구센터
연구원	유경미	대한의학회 연구센터
연구원	전정진	대한의학회 연구센터
연구원	백중서	대한의학회 연구센터

8. 참고 문헌

1. 대한의학회. 고혈압 임상진료지침 일차 의료용 근거기반 가이드라인. 2014.
2. 대한의학회. 일차 의료용 고혈압 임상진료지침 근거기반 권고 요약본. 2014.
3. 대한의학회·질병관리본부. 고혈압 관리 지침서 근거기반 환자 정보. 2014.
4. 대한의학회·질병관리본부. 고혈압 환자에게 필요한 정보. 2014.
5. 분당서울대학교병원 권역심뇌혈관센터. 고혈압의 올바른 이해. 2014.
6. 분당서울대학교병원 심장혈관센터 노인병내과. 고혈압의 흔한 질문들. 2015.
7. 대한의학회·질병관리본부. 당뇨병 관리 지침서 근거기반 환자정보. 2014.
8. 질병관리본부. 고혈압 환자 상담 및 응대 표준 매뉴얼. 2012.
9. 금연길라잡이(www.nosmokeguide.or.kr)

개발 참여 학회

고혈압 예방과 관리 정보 개발 및 발행

대한의학회

고혈압 예방과 관리 정보 개발 주관 학회

대한고혈압학회

고혈압 예방과 관리 정보 개발 참여 학회

대한내과학회

대한비만학회

대한신장학회

대한심장학회

한국지질·동맥경화학회

대한개원의협의회

대한노졸중학회

나와 가족을 위한 고혈압 예방과 관리 정보

- 발 행 일 : 2023년 12월 31일
- 펴 낸 곳 : 대한의학회 · 질병관리청
- 개발 집필 : 대한의학회 고혈압 임상진료지침 제정 및 개발위원회
- 기획 편집 : 대한의학회 임상진료지침 연구사업단
서울특별시 서초구 반포대로 14길 42(서초동) 하이앤드빌딩 6층(우.06653)
Tel: 02-6952-9602 / E-mail: guidelines@kams.or.kr
- 디 자 인 : 플레이니트 Tel: 070-3446-9922

「나와 가족을 위한 고혈압 예방과 관리 정보」는 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침정보센터 운영지원」 사업의 하나로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었습니다.



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청



9 791168 603462

ISBN 979-11-6860-346-2 (PDF)

비매품/무료

95510